Pacient 10 r.č. 103456/1010 poj.

tel.

Uroonkologie - MDT

Diagnostický souhrn:

Pacient po primobiopsii TRUS v r.2020 při PSA 7,57 ng/ml - negativní

MR prostaty 01/2026- prostata 51ml, ložiska PIRADS 4 14x10mm a 9x7mm
PSA 2026- 4ng/ml

2026- RARP
Histologie:
Mikropopis:
(1) a-m1) V kompletně zpracovaném materiálu průřezy prostatou, kde v terénu adenomyomatózní hyperplázie zastiženy struktury acinárního adenokarcinomu, Gleason skore 3+4=7. Karcinom je omezen na prostatu, postihuje fokálně apex a oba laloky. Bez známek angioinvaze a perineurálního šíření. Resekční okraje intaktní. V prostatě zastižené semenné váčky jsou intaktní.

Závěr:
1. adenokarcinom acinární
2. Gleason skore - 3+4=7
3. angioinvaze - ne
4. perineurální šíření - ne
5. karcinom omezen na prostatu, postihuje oba laloky
6. resekční okraje - intaktní
7. pT2c
8. oba semenné váčky i chámovody bez maligních struktur

Ré: favourable intermediate risk acinární adenokarcinom prostaty pT2c cN0Mx GS 3+4 iPSA 4ng/,l- stp roRAPE, R0

Doporučení:

Kontrolní PSA s odstupem 6-8 týdnů od operace, při PSA do 0,2ng/ml pečlivé sledování (PSA co 3 měsíce), při pooperačním PSA nad 0,2 nebo jeho nastoupání na hodnotu 0,2 ng/ml při dispenzarizaci doplnit staging (PSMA PET/CT) a s výsledky ad MDT.